

32 - 03- Grossesses Prolongées et Dépassement de Terme - Pr. FAKHIR

Bonjour, nous allons traiter aujourd'hui les grossesses prolongées et le dépassement de termes. C'est un cours destiné aux élèves de 5ème année des études médicales, le module de gynécologie obstétrique. Alors, par définition, la grossesse prolongée, c'est une grossesse qui dépasse les 41 semaines mémorées, et généralement, il y a plus de 15 à 20% des grossesses qui arrivent à ce terme.

On parle de dépassement de termes quand la grossesse évolue au-delà de 42 semaines mémorées révolues, et là, uniquement 1% des grossesses peuvent atteindre ce terme. Alors, cette définition est purement chronologique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de substratum anatomique ou électrique, c'est-à-dire qu'on a retenu ces dates parce que les études épidémiologiques ont montré qu'il y a une augmentation de la mortalité périnatale aux alentours de ce terme. C'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps, on a observé les grossesses, et on a vu que pour les grossesses qui dépassent les 41 semaines et qui dépassent les 42 semaines, il y a beaucoup plus de problèmes, de complications, et même de mortalité périnatale, c'est-à-dire autour, juste avant, au cours du travail ou après l'accouchement.

A l'origine de ce problème, il y a la sénescence placentaire, c'est comme un vieillissement des cellules placentaires qui commence à diminuer leurs échanges phéto-maternels et qui fait qu'il y a une sorte d'hypoxie fœtale qui va s'installer de façon chronique et qui va donner des complications qui peuvent aller jusqu'à la mort fœtale in utero. La post-maturité, généralement, donne un syndrome clinique néo-natal qui est dû à l'hypoxie fœtale de l'origine placentaire que nous allons voir. La durée normale de la grossesse varie généralement entre 280 et 290 jours à partir du premier jour des règles.

Ceci pour des cycles réguliers d'à peu près 28 jours. La durée normale de grossesse en semaines entre 40 et 41 semaines par jour, c'est une moyenne en fait. Et comme on vient de le dire, grossesse prolongée au-delà de 41 semaines améliorée s'écrit arbitrairement, c'est-à-dire qu'on est tombé sur ce chiffre, sur le plan échographique ou sur le plan histologique du placentaire, on a passé cette corrélation de 41 semaines, mais sur le plan statistique, on a observé le début des complications, c'est 41 semaines améliorées.

Puis le dépassement de termes, et là les complications sont encore plus importantes, c'est au-delà de 42 semaines. En fait, ce terme de 42 semaines ne peut en aucun cas être dépassé par la grossesse. Donc voilà, la zone du terme c'est entre 37 semaines et 42 semaines.

Avant 37 semaines, on parle de préterme ou prématurité, et au-delà de 40 semaines, on parle de terme dépassé. Et la grossesse prolongée c'est entre 41 et 42 semaines. Et cette semaine-là, qui est entre 41 et 42, c'est une semaine, si on veut attendre jusqu'à 42 semaines pour donner à la placentaire la chance d'accoucher normalement, on devrait surveiller de très près au cours de

cette semaine-là.

Alors remarquez sur ces photos-là, à droite il y a le nouveau-né qui a les yeux fermés et qui est d'aspect tout à fait normal, alors que sur le côté gauche, le fait que ce nouveau-né ait les yeux ouverts et qu'il soit éveillé, on parle d'un nouveau-né éveillé, et bien ça, ça fait partie des signes du syndrome post-natal de la grossesse prolongée. Alors généralement, on va voir qu'il y a deux termes, il y a l'aspect éveillé, il y a les cheveux, les ongles qui sont blancs, il y a l'aspect de la peau qui est un peu bridée parce que le fœtus est en déshydratation, donc vous trouvez que sa peau est bridée, remarquez le front de celui qui est à gauche par rapport au nouveau-né qui est à droite, on voit que la peau est plus hydratée que chez l'autre, et ça c'est à cause de la diminution des échanges entre les deux placentaires. Donc ce dépassement de termes survient chez un certain nombre de placentaires, mais pas chez toutes, et là on a pensé, quels sont les facteurs qui favorisent, qu'est-ce qui fait qu'une patiente fin de dépassement est âgée ou autre ? En fait, ce sont des théories variables, et ces théories-là, elles sont plutôt pourquoi le travail se déclenche spontanément chez une patiente et pas chez l'autre, qui fait que celle qui n'a pas eu son travail spontané, la grossesse prolonge.

Et donc les théories qui expliquent le début du travail sont très variables, et sont toutes des théories actuelles, il n'y a aucune confirmation à 100%, puisque c'est des éléments multifactoriels qui interviennent, et qui font que le travail va commencer à telle date, ou à telle autre date. Première théorie, c'est la théorie mécanique, c'est que quand il y a une surdistention utérine, avec des phénomènes locaux de traction, il y a une maturation cervicale myométriale, et l'accommodation phétopathienne, ceci entraîne une pression sur le col du phénomène, et ça donne un déclenchement du travail. Dans le cas inverse, où on a une hypotrophie, donc on n'a pas assez de surdistention abdominale, que la présentation n'est pas céphalique, et qu'elle est autre chose qu'un sommet, l'accommodation phétopathienne ne se fait pas correctement, et donc il n'y a pas de sollicitation du segment inférieur et du col, et puis quand il y a par exemple un obstacle prévia, qui fait que la présentation ne se fait pas au contact direct avec le col et le segment inférieur, tout ça à donner qu'il n'y a pas de déclenchement du travail, et qu'il y a un risque d'un dépassement de terme.

Donc on va dire que l'hypotrophie, ce n'est pas la prématurité, on peut être hypotrophe et aller jusqu'au dépassement de terme. La théorie immunitaire, là c'est la diminution de la réaction de tolérance materno-fœtale en fin de process. En fait, c'est une théorie de déclenchement du travail, c'est-à-dire qu'à un certain moment, il y a une chute de la progestérone, qui induit cette immunotolérance du corps maternel au fait de tout ce qu'il y a dans la gélat hétérologue, cela, quand la progestérone diminue, alors cette tolérance va diminuer, et donc l'organisme maternel va agir contre un corps étranger, et va essayer de l'expulser, et donc les contractions vont démarrer, et le travail va démarrer.

Donc le cas inverse, c'est que cette immunotolérance ne diminue pas, elle reste, et donc la process est prononcée. La théorie suivante, c'est la théorie hormonale. En fait, il y a, à la fin de

la progestérone, une diminution du rapport progestérone-œstrogène, puisque au cours de la grossesse, la progestérone est très élevée par rapport au taux d'œstrogène, c'est ce qui maintient la grossesse, ce qui maintient une tolérance immunitaire de la grossesse, ce qui maintient un relâchement de l'immunité, et donc maintient la grossesse.

Alors, vers la fin de la grossesse, et quand le travail est proche, il y a une chute de la progestérone, et donc le rapport progestérone-œstrogène va s'inverser, et c'est un signe qui va aider au déclenchement du travail. En plus de ça, il faut qu'il y ait la sécrétion des ocytocines d'origine fœtale, et on sait que les ocytocines déclenchent les contractions utérines, de vasopressine et de cortisone fœtale, tous ces éléments antérieurs pour déclencher le travail. Maintenant, quand il y a, par exemple, un fœtus de sexe masculin, et il y a un déficit enzymatique, et donc moins d'œstrogène, eh bien, peut-être que le travail se déclenchera moins vite.

Dans le cas où il y a une anencéphalie ou une hypoplasie sur un fœtus, donc il n'y aura pas de sécrétion des ocytocines par rapport aux anencéphales, puisque c'est une hormone qui est sécrétée par l'hypophyse, et puis, il n'y aura pas de cortisone fœtale, et ce qui donne un retard du déclenchement du travail, on est dans la situation de la grossesse prolongée ou du dépassement de termes. Ensuite, il y a la théorie placentaire. En fait, c'est des modifications placentaires en rapport éventuellement avec des perturbations de la réaction immunitaire materno-fœtale qui sont responsables d'anomalies des échanges vasculaires, de perturbations métaboliques à l'origine d'une sécrétion locale de prostaglandins.

Ce qui veut dire que pour un déclenchement du travail normal, il faut une sécrétion de prostaglandins. D'ailleurs, si vous vous rappelez, quand on veut faire un déclenchement artificiel du travail, on a recours à des prostaglandins. Ceci donne une maturation du col qui devient moins dure et commence à s'effacer, et puis ça déclenche un peu les contractions maternelles.

Dans le cas inverse, où ces modifications placentaires ne se font pas à temps, on va avoir un retard du déclenchement du travail, et donc une grossesse prolongée. Les facteurs d'horizon classiques, c'est-à-dire qu'on remarque par rapport aux études épidémiologiques, on remarque que les patients qui ont des antécédents de grossesse prolongée peuvent en faire encore. À l'origine ethnique, avec une incidence supérieure de grossesse prolongée dans les races blanches, un rôle de l'âge maternel qui reste controversé, celui de l'arrêt légal.

L'hypothyroïdisme maternel peut être une cause. La présence d'une toxémie gravidique peut être une cause. On parle un peu de toxémie gravidique, mais plutôt de prééclampsie.

Mais sachez qu'au cours de la prééclampsie, il y a la prématurité provoquée, il y a un déclenchement artificiel du travail qui est beaucoup plus important. Les facteurs constitutionnels ont aussi été incriminés, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font des grossesses prolongées tout simplement, sans qu'il y ait de cause évidente. Donc comment on fait le diagnostic d'une

grossesse prolongée ? Eh bien, il est très important au primordial de connaître le terme précis de la grossesse au tout début de la grossesse, afin de pouvoir, vers la fin de la grossesse, savoir est-ce que la patiente est toujours en période de terme, c'est-à-dire qu'elle est en 37 et 42, ou bien elle est en grossesse prolongée ou en dépassement de terme.

Bien évidemment, si on n'a pas une datation précise de la grossesse, on ne peut pas, à la fin, juger si on est en dépassement ou pas. Et donc, on peut faire la datation déjà par la date des dernières règles, et là, c'est un repère classique, mais il y a des conditions, il faut que le cycle soit régulier, que la patiente ne soit pas sous contraception orale pendant au moins 3 mois, et que, bien évidemment, qu'elle ait noté correctement sa date des dernières règles. A part ça, il y a la courbe thermique qui détermine l'ovulation, mais c'est une technique qui n'est plus utilisée.

Puis, si on utilise l'induction de l'ovulation ou de la stimulation, on connaît exactement la date de l'ovulation, et on peut dater correctement la grossesse. Et puis, si on est en situation de progression médicalement assistée, et on fait de la fécondation in vitro, on a exactement le jour de la fécondation, et donc on peut calculer facilement le terme de la grossesse. En dehors de ces situations-là, on va avoir du mal à calculer le terme correctement et savoir si la grossesse est prolongée ou pas.

Le terme aussi peut être déterminé par l'échographie, surtout l'échographie obstétrique entre 7 et 13 semaines, c'est-à-dire celle du premier trimestre. Et là, on mesure ce qu'on appelle la longueur crânio-codale du fœtus, qui correspond aux dates précises en fonction des courbes existantes. Cette période-là est très importante parce qu'on va remarquer que tous les fœtus, surtout entre 12 et 13 semaines, ont la même longueur crânio-codale.

Et donc, même si on n'a pas de date d'arrêt ou de date de fécondation, cette longueur crânio-codale permet l'évolution d'une date en fonction des courbes existantes. Et à partir de là, on va poursuivre la surveillance de la grossesse. Si l'échographie du premier trimestre n'a pas été réalisée et la date d'arrêt n'est pas connue, donc là, on est à peu près dans l'approximative, mais cela n'empêche qu'on peut considérer d'autres éléments.

Le BIP et le périmètre crânien devront être privilégiés avant 18 semaines. Et après 22 semaines, c'est surtout la dynamique de la croissance, c'est-à-dire qu'on devrait faire deux échographies à 15 jours ou à 1 jour d'intervalle et voir exactement la date qui correspond par rapport à ces mesures-là. Voici une image échographique d'un fœtus aux alentours de 12 semaines.

On voit déjà le pôle céphalique à droite et le pôle codale à gauche et on a le dos qui est en bas. Et là, on peut mesurer la longueur crânio-codale qui va du vertex jusqu'au niveau du coccyx. Il faut avoir une bonne coupe de profil du fœtus, une coupe saggitale, pour pouvoir mesurer correctement ces 12 traces humaines, parce que, comme je vous ai dit, il est très précis par rapport au déterminisme du terme de la grossesse.

Ici, là aussi, c'est une coupe échographique d'un BIP, c'est-à-dire un diamètre biparietal. Les os

parietaux sont de part et d'autre de haut en bas de cette image et on mesure le BIP entre les deux points, comme vous voyez. Ça nous permet aussi de donner une datation à la grossesse.

On peut aussi mesurer le périmètre crânien. Vous voyez les points tidés autour du crâne, ça nous donne le périmètre crânien. Et on remet ça sur des coupes de biométrie fœtale et ça permet de déterminer l'âge de cet os.

Donc là, c'était les critères de datation de la grossesse qui nous permettent, vers la fin de la grossesse, de suspecter la grossesse prolongée ou le dépassement du terme. Et on a dit que si on n'a pas cette datation-là, il est difficile de savoir vers la fin où est-ce qu'on est par rapport au terme. Maintenant, si on n'a pas cette datation correcte au début de la grossesse et la patiente arrive vers la fin, on peut s'entraider par des astuces échographiques pour connaître les signes de maturité fœtale et éliminer une prématurité.

Alors là, on ne va pas pouvoir dire exactement est-ce que c'est 41 semaines ou 42 semaines, mais on peut dire qu'on n'est pas dans une prématurité et donc on peut autoriser l'accrochement de cette patiente parce qu'on ne sait pas jusqu'à quel moment on va la prolonger. Alors les éléments, c'est le diamètre biparietal au-delà de 92 mm, le gradine placentaire peut nous montrer le degré de sénescence du placenta, même s'il n'y a pas de corrélation frange entre l'aspect échographique du placenta et le dépassement ou la sénescence fonctionnelle du placenta en humain. Puis, on peut chercher des points d'ossification, comme le point d'ossification féminin supérieur qui est entre 3 et 4 mm à 33 semaines, mais qu'au-delà de 6 mm, on peut dire qu'on est dans la maturité.

La même chose pour un point d'ossification un petit peu supérieur, donc à 35 semaines, il peut être déjà à 7 mm. Donc on peut aller chercher ces points d'ossification à l'échographie et dire qu'on est soit inférieur à 33 semaines, soit au-delà de 35 semaines. Le gradine placentaire, c'est un gradine de grade 9, ça s'appelle, en fait qui va du grade 0, 1, 2 et 3 en fonction de l'aspect échographique du placenta, soit qui est complètement homogène, parfois avec quelques zones décongénès au-delà du grade 0. Grade 1, on a de toutes petites calcifications éparses, pas évidentes, très peu évidentes.

Grade 2, on a des calcifications au niveau de la plaque basale, c'est-à-dire du côté de la main. Et le grade 3, vous voyez que tous les cotylédons sont entourés de calcifications, on la trouve sur la plaque basale, mais aussi sur la plaque coréale, des terminaux, ainsi que les cotylédons. Et là, on est dans le grade 3, dans le grade 3, c'est qu'on est avancé au-delà de 37 semaines minimum.

En sachant que ces calcifications, justement comme je l'ai dit, n'ont pas de corrélation fonctionnelle avec la fonction réelle du placenta, on peut avoir un aspect de calcification au grade 3, mais que le placenta fonctionne bien et qu'il n'y a pas de retentissement fatal. Voici l'image du placenta, cette partie écogène qui est supérieure et qui est reliée au fœtus par un cordon que

vous voyez au milieu, de la zone noire qui est le liquide amniotique, et puis le fœtus il est tout en bas de l'image. Alors là, on voit qu'il n'y a presque pas de calcification, et donc on est dans un grade 0 à 1. Et là par contre, vous voyez que les calcifications sur le placenta qui est en haut, elles dessinent complètement les cotylédons du côté basale et du côté coréal.

Le côté coréal c'est le côté où il y a le noir qui est le liquide amniotique, le côté basale c'est le côté de la paroi en haut. Et donc là on est déjà à un grade 3, et si on n'a pas de terme précis chez cette façon, on va s'inquiéter et dire peut-être qu'elle va entrer dans le dépassement de termes, et on doit intervenir pour l'accoucher. Maintenant, quelles sont les conséquences du dépassement de termes ? La première des choses, c'est l'hypoxie périnatale à cause de la sénescence placentaire.

Comme on le sait, le placenta permet des échanges entre la maman et le fœtus, et ces échanges intéressent l'oxygène, mais intéressent aussi les nutriments. Et donc si les échanges d'oxygène diminuent, bien évidemment on va avoir une hypoxie périnatale. Oligo-aminose avec diminution du débit utéro-placentaire, alors on sait que le liquide amniotique, son origine, c'est les urines fœtales, et donc s'il y a une diminution du débit utéro-placentaire, il y a une diminution de la volumine chez le fœtus, et donc une diminution de la diurèse, c'est ce qui fait qu'il y a un oligo-aminose.

Et d'ailleurs, l'oligo-aminose est un des signes importants qui peuvent nous orienter vers la situation du dépassement de termes. Parce qu'entre les 41 et 42 semaines, on a dit qu'il fallait surveiller de près ces grossesses-là, et entre autres, on surveillera la quantité du liquide amniotique tous les 48 heures pour juger si il y a une diminution de ce liquide, cela veut dire qu'il y a quand même une souffrance fœtale chronique, c'est que le fœtus est en diminution du débit utéro-placentaire. Puis il y a l'asphyxie périnatale, avec des anomalies du rythme cardiofœtale et acidose néonatale avec un nombre correspondant à 7. Ceci veut dire que ces fœtus qui sont en dépassement de termes, au moment du travail vont être fragilisés, et leur hypoxie va s'aggraver en asphyxie périnatale, et on va avoir des anomalies du rythme cardiofœtale, et éventuellement parfois une acidose néonatale.

Sachez que la mortalité périnatale passe de 0,7% à 5,8% si on compare entre 37 semaines et 43 semaines, c'est-à-dire un vrai dépassement de termes. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment surveiller cette période-là, parce que ça on le voit encore pour les grossesses non suivies ou qui n'ont pas de datation du début de grossesse, elles peuvent arriver à la fin et faire une mort fœtale in utero ou une asphyxie périnatale. Donc les complications les plus graves, c'est la mort fœtale in utero, et on a compris pourquoi, parce qu'il y a une diminution de l'oxygénation, il y a une diminution de la volumine, et en plus de ça, si la personne rentre au travail, le fœtus est fragilisé, et il peut faire une souffrance fœtale et une asphyxie.

Après, on peut avoir une inhalation du liquide méconial, pourquoi on parle de liquide méconial ici ? Parce qu'on sait que quand il y a de l'hypoxie, il y a une émission du liquide méconial, et je

pense que vous l'avez déjà vu dans d'autres chapitres de la souffrance de la asphyxie périnatale. Quand il y a de l'hypoxie, il y a une stimulation du transit intestinal du fœtus qui va émettre son méconium in utero, et à la naissance, le méconium est tellement épais que quand il y a une inhalation du méconium, cela va engendrer des complications respiratoires postnatales assez sérieuses. Les troubles métaboliques, et ça c'est à cause des échanges qui sont modifiés, et puis quand l'hypoxie ou la souffrance sont importantes, on peut avoir des complications neurologiques sérieuses.

Les conséquences du dépassement de termes qu'on peut voir en postnatale, c'est un certain nombre de postmaturité. Déjà, les mensurations sont parfois supérieures à celles d'un nouveau-né interne, tant pour la taille que pour le périmètre crânien. Pourquoi ? Parce que des fois, il y a la souffrance rotale chronique qui s'installe, c'est-à-dire qu'il y a une diminution du débit utéro-placentaire, que les échanges diminuent, et donc le fœtus va réagir comme en retard de croissance chronique, et il va arrêter sa croissance, et on va avoir l'arrêt de la croissance.

Parfois, malgré la prolongation de la grossesse, le placenta continue à fonctionner normalement, presque normalement, et donc les échanges continuent, le fœtus continue à grossir, et donc on va avoir des gros bébés à la naissance, et c'est une macrosomie, avec tous les risques de traumatismes obstétricaux qui sont sus. Cliniquement, quand on regarde un nouveau-né postmature, comme je vous ai montré sur la photo, c'est un fœtus qui va avoir une peau sèche, qui est parcheminée, qui est craquelée, avec des fissurations au point de flexion, et absence de l'anégo et du vernis casé. Les ongles et les cheveux sont longs, avec parfois une disquantation, et puis on peut faire la confirmation radiologique, qui montre les ossifications plus importantes, mais ça on ne le fait presque jamais.

Et puis un comportement alerte, avec les yeux ouverts, et un aspect éveillé du nouveau-né, qui normalement sont tous les yeux fermés, un peu bouffés, etc. Alors les post-termes, ils sont bien élevés. Les autres conséquences du dépassement de termes, c'est les taux de césarienne, qui vont être 2 à 3 fois plus élevés, après les 42 semaines d'amélioration.

Après avoir fait le diagnostic, et avoir compris les conséquences qui peuvent être graves, de la grossesse prolongée, on devrait avoir une attitude particulière quand la grossesse arrive à 41 semaines d'amélioration. Il faut obligatoirement avoir en tête ce problème de complication du dépassement de termes, et donc on doit instaurer une surveillance entre 41 semaines et 42 semaines. C'est une surveillance qu'on peut commencer déjà à 40 semaines, puisqu'il a été établi que des signes de post-maturité peuvent apparaître plus tôt que 41 semaines d'amélioration, chez pas mal de grossesses, et donc il faut être vigilant dès 40 semaines d'amélioration.

Et donc, il faut pouvoir surveiller ces patientes moins de 2 à 3 fois par semaine, et les moyens de surveillance, la première des choses, c'est éduquer la patiente, surveiller les mouvements actifs plus tôt, puis faire l'ERCF, c'est-à-dire l'enregistrement du rythme cardio-fœtal, qui est l'éliminant

des premières lignes, et on devrait le faire toutes les 48 heures, et chercher les anomalies de rythme, type tachycardie, ou micro-oscillations, ou disparition des accélérations, ou encore apparition de décélérations. Et puis, faire l'échographie, là aussi, 2 à 3 fois par semaine, afin de mesurer le liquide amniotique, et chercher l'oligoamniose. Alors, on le mesure par la mesure de la grande citerne, et on parle de l'oligoamniose si la grande citerne est inférieure à 2 cm.

Le Doppler, est-ce qu'il est utile pour le dépassement de termes? En fait, il n'est pas très recommandé pour le dépassement de termes, pas comme dans les retards de fréquence et vitéros, ou l'aparition, parce que les effets Doppler ont besoin de plusieurs semaines pour apparaître, et donc, l'inconscience prolongée du dépassement de termes, c'est question d'une à deux semaines, et donc, on n'a pas le temps de surveiller le Doppler. Le scope de physique de Meiningen ne le fait plus, et l'amnioscopie, qui autrefois a été utilisée pour voir la qualité et la couleur du liquide amniotique, elle n'est plus utilisée actuellement. Donc, après la surveillance de ces grossesses prolongées, il faut décider à quel moment on peut déclencher le travail, et le déclenchement de travail se fait artificiellement, en général, entre 41 semaines et 42 plusieurs jours.

Je voulais vous dire que ça fait quand même beaucoup pour décider, en fait, cela dépend des moyens de surveillance. Est-ce que vous avez les moyens de surveillance, et donc, vous pouvez aller jusqu'au bout qui est à 42 plus 6, ou bien vous n'avez pas les moyens de surveillance, et donc là, vous devez déclencher à 41 semaines, ou bien, entre temps, au moment de votre surveillance, vous retrouvez qu'il y a une diminution du liquide amniotique, ou une anomalie de l'ERCF, qui vous oblige à intervenir. Maintenant, on parle du déclenchement artificiel du travail, bien évidemment, avec de bonnes conditions obstétricales, c'est-à-dire une présentation somnée, pas de macrosomie, pas de souffrance fœtale, pas de contre-indications autres à l'accouchement parvasque, comme les utérus doublément cicatriciels, etc.

Si on décide de déclencher, quels sont les moyens de déclenchement artificiel du travail ? Premièrement, il y a les oocytocines, qui déclenchent la décontraction de l'ampléothérie, puis il y a les prostaglandines, il existe des prostaglandines naturelles, et des prostaglandines de synthèse. En sachant que les prostaglandines ont un rôle très important, qui est la maturation cervicale, quand le Bishop est défavorable, quand le score de Bishop cervical est défavorable, c'est-à-dire que le col est épais, il est long, il est fermé, il est postérieur, que la présentation est haute. Ce sont les éléments du Bishop qui font que si le col a un score de Bishop faible, on ne peut pas mettre les oocytocines directement, parce que ça ne va pas ouvrir le col, créer des contractions, mais le col ne s'ouvrira pas, ce qui n'est pas mature.

Les prostaglandines permettent de faire une maturation cervicale avant de mettre les oocytocines. La maturation cervicale se comprend, ou plutôt se reconnaît, par le changement de l'aspect dur du col qui devient mou, l'aspect complètement fermé qui devient ouvert, un bois par exemple, l'aspect postérieur qui devient un peu central, et puis la présentation qui devient fixée au lieu d'être mobile par exemple. Là, on sent que les oocytocines vont être capables d'agir sur

ce col pour l'ouvrir par la suite, par l'intermédiaire des contractions internes.

On peut aussi faire une maturation cervicale par un décollement des mains, si on a un col qui admet un petit doigt, on peut arriver à décoller entre les membranes et le segment inférieur. Ceci va faire libérer des prostaglandines naturelles et va intervenir pour faire la maturation cervicale, le déclenchement du travail. On peut aussi utiliser ce qu'on appelle des moyens mécaniques comme le centre de folie qui va gonfler entre les membranes et le segment inférieur aussi, à travers le col.

Il y a des lamineurs qui sont des petits bâtonnets qu'on met dans le col et qui vont gonfler par les sécrétions nos cervicales. Ceci va dilater un peu le col et décoller le membrane et libérer les prostaglandines et donc maturer le col. Pour vous dire que les prostaglandines ont un rôle très important dans la maturation cervicale qui, par la suite, va faciliter l'action des contractions utérines pour la dilatation du col.

Le score de Bishop c'est ce que vous voyez sur ce tableau. Il contient 5 éléments qui sont la dilatation du col, la longueur du col, la consistance du col, la position du col et la présentation. Chacun de ces éléments est coté entre 0 et 3 et la somme de ce score va nous donner soit que ce score est inférieur à 6 et là on est dans un Bishop défavorable au déclenchement par les ocytocines.

On ne dit pas qu'il est défavorable pour l'accouchement par voix basse, non. Il est défavorable à l'action des ocytocines. C'est-à-dire que si on met du synthocine sur un col avec un Bishop inférieur à 6, on devrait s'attendre qu'il n'y ait pas une grande action d'ouverture du col.

Mais si le Bishop est supérieur à 6, ça veut dire par exemple, au moins qu'il est central, qu'il est mou, que la présentation est fixée par exemple en anglais, et bien là on peut s'attendre à une réponse favorable suite à l'utilisation des ocytocines. Dans le cas où le Bishop est inférieur à 6, on va se dire non, on a besoin de faire une maturation cervicale par les prostaglandines avant de mettre les ocytocines. Quand on a un utérus cicatriciel, sachez qu'on peut faire un déclenchement artificiel du travail par les ocytocines si le Bishop est favorable.

Alors que les prostaglandines naturelles ou misoprostoles, qui sont des prostaglandines de synthèse, sont proscrits en cas d'utérus cicatriciel parce qu'il y a un risque de rupture de la cicatrice ou de déhiscence de la cicatrice. Pour la présentation de siège, il n'y a pas de contre-indications en déclenchement du travail. Bien évidemment, il faut respecter toutes les conditions nécessaires pour l'accouchement à base d'un siège, notamment l'estimation de poids, la flexion de la tête, le bassin, etc.

Pour la multiparité, là, il faut faire attention quand on fait un déclenchement artificiel du travail, s'il y a un risque de rupture utérine, il n'y a pas de contre-indications en déclenchement, mais ceci veut dire que le déclenchement devrait se faire sous haute surveillance avec une surveillance

continue des contractions utérines et de l'ERCF par un monitoring continu du travail. Pour le déroulement de l'accouchement, après la réussite et le déclenchement du travail, c'est la même surveillance que les autres procès, un monitoring continu des contractions utérines, une rupture artificielle des membranes précoces parce que quand on fait un déclenchement artificiel du travail, dès qu'on a accès à la poche des os, il faut remplir la poche des os parce que ça libère encore plus des prostagones et ça permet d'activer le travail et de ne pas le prendre à l'événement. Il faut faire attention quand on déclenche sur un fœtus en dépassement du terme que le fœtus est fragile et donc il faut aller avec les doses bien contrôler le cytokine et surveiller pour qu'on continue le rythme cardio-fœtal et puis on sait déjà qu'il y a un risque plus élevé de ces variants quand on fait des déclenchements artificiels du travail parce qu'on peut avoir un échec de déclenchement, c'est-à-dire que le cône ne s'ouvre jamais malgré les prostagones et les cytokines ou bien quand on a des complications comme l'hypersinésie ou comme l'hypersimulation ou encore quand on a des anomalies de l'ASF puisque c'est des fœtus qui sont déjà fragiles.

Enfin, après la naissance, il y a prise en charge les nez en atales particulières donc c'est des nouveaux nez qu'il faut penser à préparer une aspiration farangée avant le déclenchement des épaules surtout si le liquide est implanté au méconial il faut savoir pratiquer l'intubation et l'aspiration à l'eau trachiale si le méconial est là comme on l'a dit puisque parfois il peut y avoir un liquide méconial été qui est une infusion donc l'intubation systématique des nouveaux nez n'est pas recommandée pour surveiller la glycémie du nouveau nez et les microbes et surveillance d'une polyhumidité. Donc, en conclusion il faut retenir que le dépassement de terme c'est une situation qui n'est pas rare et qu'il faut la guider et la surveiller et pour cela l'étape la plus importante c'est le déterminisme de l'âge gestationnel au début de la grossesse si on ne fait pas ce déterminisme, sachez qu'il y aura un problème à la fin de la grossesse pour savoir exactement où on est est-ce qu'on est dans une situation de dépassement ou bien est-ce que on est encore au terme normal et bien évidemment dès qu'on arrive à 40-50 du nez, on devrait surveiller ces patients tout de près les éléments de surveillance c'est le RCF c'est l'échographie pour voir le liquide amnésique Je vous remercie